

Infecções do Trato Genital Feminino e Úlceras Genitais – Avançada

Definições Fundamentais

Primeiramente, precisamos alinhar o conceito. **Violência sexual** é todo e qualquer ato sexual realizado **sem consentimento**. Isso inclui não apenas o estupro com penetração, mas também o **atentado violento ao pudor** e qualquer ato sexual ou libidinoso praticado contra a vontade da vítima. Esse ponto é uma pegadinha clássica de prova: violência sexual não se resume à penetração.

Já o **estupro de vulnerável** se aplica quando a vítima é **menor de 14 anos**, possui **incapacidade mental** ou, por qualquer razão, não é capaz de resistir à violência ou de consentir a relação sexual. A lógica aqui é que essas pessoas não possuem discernimento suficiente, e por isso a lei presume a violência independentemente de qualquer outro fator.

Um ponto importantíssimo: a violência sexual é um **agravo de notificação compulsória**, que deve ser notificado em até **24 horas**. Quando a vítima é criança ou idoso, é necessário comunicar ao respectivo conselho — o **Conselho Tutelar** no caso de crianças e adolescentes, e o **Conselho do Idoso** quando pertinente.

E atenção a um detalhe que as provas adoram cobrar: o **boletim de ocorrência é opcional**. Ele é um direito da paciente, uma escolha dela. O atendimento médico **nunca** pode ser condicionado à apresentação do B.O. Se a paciente quiser registrar, ótimo; se não quiser, o atendimento segue normalmente. Grave isso com força, porque essa informação aparece com frequência nas provas e é determinante para acertar questões sobre o tema.

Atendimento à Vítima de Violência Sexual

O atendimento à vítima de violência sexual é **multidisciplinar**. Essa paciente precisa ser acolhida por uma equipe composta pelo médico, que vai prescrever todas as profilaxias, pela **psicóloga**, que fará o acompanhamento do estresse pós-traumático, e pela **assistente social**, já que muitas dessas pacientes vivem em situação de vulnerabilidade. Os pilares desse atendimento são: **acolhimento qualificado e humanizado**, em um momento de extrema dor e fragilidade.

Na **anamnese**, a gente precisa obter informações essenciais, mesmo sabendo que é extremamente doloroso para a paciente. O ideal é que **uma única pessoa** colha todo o relato, para que a vítima não precise repetir a história várias vezes e reviver o trauma. As informações que precisamos são: **há quanto tempo ocorreu a violência, qual o tipo de penetração** (vaginal, anal, oral), se houve **violência física associada** (hematomas, lacerações), o **número de agressores** e se eram **conhecidos ou desconhecidos**. Tudo isso muda diretamente a conduta.

Quanto ao **exame físico**, se a paciente não quiser, é um direito dela recusar. Mas, se ela consentir, devemos avaliar hematomas e lacerações, corrigir alterações quando presentes e, se necessário, coletar **material de vestígios**. Também é possível encaminhar a paciente ao **Instituto Médico Legal**, caso seja do desejo dela. Nada disso é obrigatório, assim como o boletim de ocorrência.

Além da anamnese e do exame físico, devemos coletar **sorologias e testes rápidos**. Um ponto crucial: **não é necessário aguardar o resultado da sorologia para iniciar as profilaxias**. Basta o teste rápido. Fazemos a **notificação compulsória** e orientamos o **seguimento sorológico** (a cada quatro semanas, três meses e seis meses), já que a paciente pode estar em janela imunológica no momento do atendimento. E, como já falamos, o **seguimento psicológico** é indispensável.

Profilaxias Virais

HIV – Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

A profilaxia para o HIV é indicada quando a paciente tem **teste rápido negativo**, o agressor é **desconhecido ou sabidamente HIV positivo**, houve **exposição a material de risco** (sangue, sêmen, fluidos vaginais) e a agressão ocorreu **há menos de 72 horas**. Quanto mais precoce o início, maior a eficácia.

Quando eu NÃO faço a PEP? Se a violência ocorreu há mais de 72 horas, se o agressor é sabidamente HIV negativo, se houve uso de preservativo, se a paciente já é HIV positiva, se a penetração foi exclusivamente oral ou em casos de **abuso crônico** em que já se ultrapassou a janela de 72 horas.

O esquema utilizado é o **Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir** (o famoso "trio" da terapia antirretroviral), por **28 dias**. Vale lembrar: esse é o mesmo esquema de primeira linha para tratamento do HIV, mas aqui usado como profilaxia.

HPV – Vacina Quadrivalente

Essa é uma atualização recente e, por isso, muito quente para provas. Agora, vítimas de violência sexual entre **9 e 45 anos** devem receber a **vacina quadrivalente contra HPV**. O esquema varia conforme a faixa etária: de **9 a 14 anos** (ou seja, até 15 anos incompletos), são **duas doses** com intervalo de seis meses; de **15 a 45 anos**, são **três doses** no esquema **0, 2 e 6 meses**.

Hepatite B

Para hepatite B, a conduta depende do **status vacinal** da paciente. Se ela já tem o esquema completo com três doses, está protegida. Se o esquema está incompleto, devemos **atualizar** as doses faltantes. A **imunoglobulina** para hepatite B está indicada quando a paciente **não tem nenhuma dose da vacina**, quando o agressor é **sabidamente HBsAg positivo** ou quando a paciente pertence a um grupo de risco. O prazo para a imunoglobulina é de até **14 dias**, mas o ideal é administrar em **48 horas**.

Hepatite C

Para hepatite C, infelizmente, **não existe profilaxia disponível**. A conduta se resume ao **seguimento sorológico** da paciente.

Profilaxias Não Virais (ISTs Bacterianas e Parasitárias)

As profilaxias não virais devem ser realizadas para **todas as exposições de risco**, de preferência com **início imediato** e em até **14 dias**. No caso de **abuso crônico**, algumas referências orientam ponderar o risco-benefício, mas na prática a tendência é fazer para todas as pacientes. Fique atento, porque a sua prova pode cobrar esse limite de 14 dias.

Aqui vai o esquema que você precisa decorar:

Clamídia — Azitromicina 1 g, via oral, dose única.

Gonorreia — Ceftriaxona 500 mg, intramuscular, dose única.

Sífilis — Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única.

Tricomoniase — Metronidazol 2 g, via oral, dose única.

Um macete para memorizar: são quatro infecções, todas tratadas em **dose única**, o que facilita bastante a adesão em um momento de tamanha fragilidade emocional. Clamídia e tricomoniase são via oral; gonorreia e sífilis são intramusculares.

Contracepção de Emergência

A profilaxia de gestação é outro pilar fundamental. Devemos oferecer **contracepção de emergência** a toda paciente com possibilidade de engravidar, **independentemente da fase do ciclo menstrual**. Esse é outro ponto clássico de prova: não importa se a paciente está no período fértil ou não, a contracepção de emergência deve ser oferecida.

A exceção é quando a paciente já utiliza um **método anticoncepcional de alta eficácia** (DIU, implante subdérmico, injeção trimestral). Nesse caso, ela já está protegida e não há necessidade.

O prazo é de até **120 horas** (cinco dias), mas idealmente até **72 horas**. Como sempre: quanto antes, melhor.

O esquema mais utilizado e difundido é o **Levonorgestrel 1,5 mg**, via oral, dose única. O mecanismo de ação é **inibir ou atrasar a ovulação** – ou seja, ele **não é abortivo**, pois impede a fecundação. Esse é um conceito importantíssimo e frequentemente cobrado: o levonorgestrel não tem efeito após a fecundação.

O esquema mais antigo, chamado **método de Yuzpe**, utiliza etinilestradiol + levonorgestrel em duas doses com intervalo de 12 horas. Ele também atua inibindo ou atrasando a ovulação, mas causa mais efeitos colaterais e por isso foi substituído na prática pelo levonorgestrel isolado.

Uma terceira opção, menos difundida mas **mais eficaz**, é o **DIU de cobre**, que pode ser inserido em até **120 horas**. Ele também impede a fecundação através de sua ação irritativa local. Porém, na prática, muitas pacientes estão fragilizadas e com dor, o que pode dificultar a realização do exame especular. Ainda assim, devemos oferecer essa possibilidade quando disponível no serviço.

Interrupção Legal da Gestação Decorrente de Violência Sexual

Agora, vamos supor que a paciente não procurou atendimento a tempo – por vergonha, medo, desinformação – e acabou ficando grávida em decorrência da violência. A **lei brasileira** garante a essa paciente o direito de **interromper a gestação**. O **Código Penal não estabelece limite de idade gestacional**, mas o **Ministério da Saúde** recomenda que a interrupção seja realizada em até **20 a 22 semanas**.

Para proceder com a interrupção legal, são necessários **quatro documentos**:

1. Relato circunstanciado da violência — a paciente faz um relato detalhado do que aconteceu, descrevendo as circunstâncias da violência.

2. Assinatura do médico responsável — o médico assina declarando que está ciente e concorda com o procedimento.

3. Termo de responsabilidade da paciente — como o aborto ainda é tipificado como crime no Brasil (exceto nos casos permitidos por lei), a paciente se responsabiliza pela veracidade do relato. Se ela estiver mentindo, responde por **falsidade ideológica e aborto criminoso**.

4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido — o consentimento formal para a realização do procedimento.

Importante: para **menores de 18 anos**, é necessária a **autorização do responsável legal**. Para **menores de 14 anos**, deve-se obrigatoriamente acionar o **Conselho Tutelar**.

Outro ponto relevante: o médico tem o direito de **objeção de consciência**, ou seja, pode se recusar a realizar o procedimento por convicções pessoais. Contudo, ele é obrigado a **encaminhar a paciente a outro profissional** que realize a interrupção. Porque, da mesma forma que a objeção é um direito do médico, a interrupção legal é um **direito da paciente**.

Perceba que em nenhum momento se exige **boletim de ocorrência** ou **exame de corpo de delito** para a interrupção legal.

Resumo dos Gatilhos

Profilaxias Virais: HIV com Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir por 28 dias (até 72 horas); Hepatite B com atualização vacinal e imunoglobulina se indicada (até 14

dias); Hepatite C sem profilaxia, apenas seguimento sorológico; HPV com vacina quadrivalente (duas doses entre 9-14 anos; três doses entre 15-45 anos).

Profilaxias Não Virais (dose única): Clamídia com Azitromicina 1 g VO; Gonorreia com Ceftriaxona 500 mg IM; Sífilis com Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI IM; Tricomoníase com Metronidazol 2 g VO.

Contracepção de Emergência: Levonorgestrel 1,5 mg VO dose única (primeira opção) ou DIU de cobre, ambos até 120 horas, idealmente até 72 horas. Não realizar se a paciente já usa método de alta eficácia. Não é abortivo.

Interrupção Legal da Gestação: Quatro documentos obrigatórios (relato circunstanciado, assinatura médica, termo de responsabilidade, TCLE). Sem necessidade de B.O. ou corpo de delito. Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável. Menores de 14 anos exigem acionamento do Conselho Tutelar. Médico pode exercer objeção de consciência, mas deve encaminhar a outro profissional.